



Doe grondig onderzoek naar de actuele administratieve druk (regeldruk) in de Nederlandse welzijnssector en transitie-interviews (bijv. rapporten van IZZ, Berenschot, of de Rijksoverheid van de afgelopen 24 maanden). Ik heb specifieke data nodig over:

Welk percentage van de werkweek besteedt een gemiddelde welzijnswerker of zorgprofessional aan administratie (zoals Wmo-rapportages, dagrapporten, subsidieverantwoording)?

Wat zijn de belangrijkste knelpunten (bijv. dubbele registratie, complexe software)?

Zoek naar concrete voorbeelden of use cases in Nederland waar generatieve AI (zoals spraak-naar-tekst voor verslaglegging of automatische samenvattingen) succesvol is ingezet om deze druk met minstens 30% tot 50% te verlagen.

Output vereisten: Lever concrete statistieken, percentages, de namen van de rapporten/bronnen en praktijkvoorbeelden. Geen algemeenheden, focus puur op de Nederlandse context (Wmo/Welzijn).

In het Nederlandse sociaal werk en de Wmo/Welzijn gaat grofweg een derde van de werktijd op aan administratie (circa 32–37%), terwijl professionals zelf rond de 20% als acceptabel zien. Er zijn inmiddels Nederlandse pilots met generatieve AI (o.a. Amersfoort, Wmo-consulenten; AI-whitepaper ValueCare; landelijke praktijkproef uit het regeerprogramma) waar voor de verslagleggingsstap tijdsreducties van ongeveer 50% of meer worden beoogd of gerapporteerd, maar grootschalig en structureel 30–50% minder regeldruk in het brede Wmo/welzijnsproces is nog vooral doelstelling en niet standaard praktijk.^{[1] [2] [3] [4] [5] [6]}

Kerncijfers administratieve tijdsbesteding

Zorg en welzijn algemeen (CBS, Berenschot, VvAA)

- Het CBS becijfert dat werknemers in de brede gezondheids- en welzijnszorg in het tweede kwartaal 2025 gemiddeld 31% van hun werktijd besteden aan administratie (verslaglegging + registraties), tegenover 47% directe zorg/ondersteuning.^[5]
- Binnen de categorie “sociaal werk” ligt de administratieve tijd op ongeveer 18,7% voor verslaglegging en 13,0% voor registreren van organisatie-informatie, samen circa 31,7% van de werktijd.^[5]
- Berenschot laat in de langdurige zorg (VVT, GHZ, GGZ) zien dat zorgprofessionals in 2024 gemiddeld 36% van hun werktijd aan administratieve taken besteden, en in de

meting over 2025 circa 34%; zij vinden rond 23% acceptabel.^{[7] [8] [9]}

- De Nationale [Ont]Regelmonitor 2023 (VvAA) concludeert dat 84% van de zorgprofessionals geen daadwerkelijke afname van administratiedruk ervaart; de ervaren regeldruk is eerder toegenomen.^[10]

Specifiek sociaal werk / Wmo-welzijn (Movisie, Sociaal Werk NL, gemeenten)

- Movisie-rapport “De stand van administratie- en regeldruk in het sociaal werk. Alle ballen in de lucht houden” (2023) onder bijna 200 sociaal werkers (Wmo-teams, maatschappelijk werk, ambulante begeleiding e.d.):
 - Gemiddeld gaat 37% van de werktijd op aan administratie en regels.^{[11] [6]}
 - Sociaal werkers vinden gemiddeld 19% administratietijd acceptabel.^{[6] [11]}
 - Circa 80% ervaart regelmatig ergernis en stress door administratie en regeldruk.^{[11] [6]}
- Sociaal Werk Nederland vat dit samen als: “sociaal werkers zijn gemiddeld meer dan een derde van hun tijd kwijt aan administratie en regels”, met dezelfde 37% vs. 19% cijfers.^{[12] [13]}
- In een motie van de gemeenteraad Hilversum (2023) wordt expliciet gesteld dat “administratie op dit moment gemiddeld 37% van de werktijd van sociaal werkers kost en 80% hierdoor stress ervaart”, verwijzend naar VWS/Movisie-cijfers.^{[14] [15]}

Beleidsdoelen rondom administratietijd

- In het Integraal Zorgakkoord (IZA) is afgesproken om uiterlijk eind 2025 de administratieve lasten met 2 uur per week per hulpverlener terug te dringen ($\approx$ 5% van een fulltime werkweek).^{[16] [3]}
- In het regeerakkoord en het Aanvullend Zorg en Welzijn Akkoord (AZWA) is het doel aangescherpt: per 1 januari 2030 maximaal 20% van de werktijd aan “zinnige administratie” in alle sectoren van zorg én welzijn.^{[3] [17]}
- IZA-partijen (waaronder NVZ) spreken expliciet over het halveren van de administratieve last van circa 40% naar 20% vóór 2030.^[18]

Overzichtstabel (relevante cijfers)

Domein / bron	Jaar (publicatie / meting)	% werktijd administratie	Gewenst / norm	Opmerkingen
Sociaal werk (Movisie)	Onderzoek 2022, gepubliceerd 2023	37% ^{[6] [11]}	19% acceptabel ^{[6] [11]}	Wmo-teams, maatschappelijk werk, ambulante begeleiding
Sociaal werk (CBS StatLine)	Q2 2025	$\approx$ 31,7% (18,7% verslaglegging, 13,0% registreren) ^[5]	n.v.t.	Breed gedefinieerde beroepsgroep “sociaal werk”
Gezondheids- en welzijnszorg totaal (CBS)	Q2 2025	31% ^[5]	n.v.t.	Alle zorg- en welzijnssectoren samen

Domein / bron	Jaar (publicatie / meting)	% werktijd administratie	Gewenst / norm	Opmerkingen
Langdurige zorg (Berenschot)	2024	36% ^[8]	23% acceptabel ^[8]	GGZ, GHZ, VVT
Langdurige zorg (Berenschot)	2025	34% ^[7] ^[9]	23% acceptabel ^[7] ^[9]	>2.000 respondenten
Beleidsdoel IZA/AZWA	Doeljaar 2030	Max. 20% ^[3] ^[17]	–	Geldt expliciet ook voor welzijn/Wmo

Belangrijkste knelpunten in Wmo/sociaal werk

Uit het Movisie-onderzoek en de bijbehorende infographic komt een duidelijke top-7 van meest belastende administratieve onderdelen in het sociaal werk. ^[6] ^[11]

Top-7 meest belastende administratieve taken volgens sociaal werkers ^[11] ^[6]

1. Rapporteren: 82% noemt dit belastend (voortgangsrapportages, verslagen van contactmomenten).
2. Kwaliteits- en verantwoordingssystemen: 77,4% ervaart hoge druk (aanleveren data voor ISO/HKZ/NEN, gemeentelijke verantwoordingformats).
3. Papier- en formulierwerk van bewoners: 73,6% (helpen bij aanvragen van Wmo-voorzieningen, toeslagen, minimaregelingen, bezwaarprocedures). ^[6] ^[11]
4. Ondersteuningsplan en dossiervorming: 72% vindt dit belastend; plannen zijn vaak lang, sterk gericht op verantwoording en sluiten taalmatig niet aan bij inwoners. ^[11] ^[6]
5. AVG-handelingen: 72% ervaart druk door onduidelijkheid over wat wel/niet mag, toestemming, gegevensdeling. ^[6] ^[11]
6. Tijdschrijven: 68% ervaart dit als belastend, vooral waar alleen direct cliëntcontact declarabel is en alle andere tijd (overleg, reistijd, denktijd) onder druk komt te staan. ^[11] ^[6]
7. Aanvragen van indicaties en beschikkingen: 63% geeft dit als zwaar aan, door stroperige processen, verschillen tussen gemeenten, korte indicatieduren en veel herindicaties. ^[6] ^[11]

Structurele oorzaken (Movisie)

Movisie koppelt deze knelpunten aan een aantal structurele oorzaken: ^[6]

- Overheids- en gemeentelijk beleid: gemeenten vragen gedetailleerde data om “grip” op uitgaven te krijgen, maar die sluiten vaak niet aan bij de bedoeling van het werk, wat leidt tot veel rapportage die als zinloos voelt. ^[6]
- Registratiesystemen: meerdere, slecht op elkaar aangesloten cliëntvolgsystemen en tijdschrijfsystemen; systemen zijn gebruiksonvriendelijk en soms leidend in plaats van ondersteunend. ^[6]
- Organisatie van het werk: management stuurt sterk op cijfers en declarabiliteit, met weinig terugkoppeling, waardoor registreren vooral als controle-instrument wordt ervaren. ^[6]

- Complexere hulpvragen: zwaardere casuïstiek vraagt meer verslaglegging en multidisciplinaire afstemming.^[6]
- Wantrouwen en onduidelijke herkomst van regels: professionals weten vaak niet of iets “moet van de wet”, van de gemeente of van de eigen organisatie; daardoor wordt er nauwelijks meer durven weglaten.^[6]

Deze analyse sluit aan bij bredere signalen van de Regiegroep Aanpak Regeldruk: veel administratie is double check, wordt in verschillende systemen opnieuw ingevoerd en is niet direct herleidbaar tot betere zorg of ondersteuning.^[19] ^[3]

Transitie- en monitorrapporten (IZZ, Berenschot, Rijksoverheid)

Stichting IZZ – Monitor Gezond Werken in de Zorg

- De “Monitor Gezond Werken in de Zorg 2023” van IZZ (met o.a. Universiteit Utrecht en Leiden) onder ruim 5.000 zorgmedewerkers laat een sterke relatie zien tussen hoge administratieve lasten, ervaren werkdruk en emotionele uitputting.^[20]
- Ongeveer 1 op de 6 zorgmedewerkers voelt zich emotioneel uitgeput; bureaucratie en onnodige regels worden expliciet genoemd als belangrijke factoren.^[20]

Hoewel IZZ niet per sector een precies percentage administratietijd publiceert, worden administratieve lasten en onnodige bureaucratie in deze monitors consequent als kernfactoren in werkdruk en ziekteverzuim benoemd, ook in de langdurige zorg en wijkverpleging (relevant voor jouw doelgroep van sociaal-domein-adjacent werk).^[21] ^[20]

Berenschot – Administratieve belasting langdurige zorg

- De Berenschot-enquêtes “Administratieve belasting langdurige zorg” laten zien dat de administratieve tijd al jaren rond de 34–36% ligt in VVT, GHZ en GGZ, met kleine schommelingen maar geen structurele daling.^[8] ^[9] ^[7]
- 79% van de respondenten ervaart administratie als belastend; het acceptabele niveau ligt stabiel rond 22–24%.^[9] ^[7]
- De meeste tijd gaat volgens Berenschot in deze sectoren zitten in cliëntdossiers/elektronische cliëntdossiers (ECD), rapportages, overleg/overdracht en interne registraties.^[7] ^[8]

Hoewel dit onderzoeksdomein formeel “langdurige zorg” is, overlapt het qua problemen sterk met Wmo-gefinancierde begeleiding en dagbesteding in de welzijnssector (zelfde typen dossiers, indicaties en verantwoordingslijnen).^[22]

Rijksoverheid / Regiegroep Aanpak Regeldruk / AI-rapport

- De Regiegroep Aanpak Regeldruk (onder IZA en AZWA) heeft in haar “Plan van aanpak” en op [Zorgakkoorden.nl](https://www.zorgakkoorden.nl) vastgelegd dat per 2030 maximaal 20% van de werktijd aan zinnige administratie is toegestaan in alle sectoren, inclusief sociaal domein.^[16] ^[3]
- In deze stukken is ook afgesproken dat per eind 2025 de administratieve tijd met 2 uur per week per fte wordt teruggebracht t.o.v. 2020-niveau.^[17] ^[3]

- Het Rijksoverheid-rapport “Van werkdruk naar werkplezier: de impact van AI op administratieve processen in de zorg” (2025) bundelt praktijkcasuïstiek over AI-toepassingen die administratieve processen verkorten; het bevat meerdere cases, maar de publieke samenvatting geeft geen uniforme sector-brede percentages, slechts dat er aantoonbare potentie is voor forse reductie van administratieve lasten.^[23]

Generatieve AI in Wmo/welzijn: Nederlandse praktijkvoorbeelden

Hieronder een selectie van concrete Nederlandse voorbeelden, met focus op Wmo/sociaal domein en nauw verwante domeinen. Ik onderscheid:

- A. Wmo/Welzijn-specifieke pilots
- B. Zorgbrede voorbeelden die qua use case transfereerbaar zijn naar welzijn / vrijwilligersmanagement

A. Wmo / sociaal domein

1. Amersfoort – AI-rapportage-assistent intake Wmo/Jeugdwet

- De gemeente Amersfoort heeft in het landelijke algoritmeregister de “Rapportage-assistent intake Wmo/Jeugdwet” aangemeld, een AI-assistent die tijdens intakegesprekken met inwoners een concept-rapportage genereert.^[4]
- Doel: administratiedruk bij wijkteammedewerkers verlagen door automatische transcriptie en concept-verslagen, die de professional vervolgens corrigeert en aanvult.^[4]
- In de officiële beschrijving staat dat een “tijdsbesparing van 50 tot 75% wordt beoogd om gesprekken te verwerken in een concept-rapportage”, waarbij de tool dus specifiek de verslagleggingsstap drastisch moet verkorten.^[4]
- Status: het algoritme staat als “in gebruik”; resultaten over daadwerkelijk gerealiseerde tijdwinst zijn nog niet breed gepubliceerd, maar als referentie is dit een Wmo-specifieke toepassing met een expliciet kwantitatief reductiedoel ($\geq 50\%$).^[4]

Voor jouw productontwikkeling interessant: dit gaat precies over het automatisch genereren van verslaglegging na keukentafelgesprekken/intake – een directe analoog van Wmo-, welzijns- en vrijwilligersgesprekken.

2. Gemeente Hengelo – MediScribe-pilot voor Wmo-keukentafelgesprekken

- Deloitte en de gemeente Hengelo voerden een pilot uit met de AI-tool MediScribe om keukentafelgesprekken van Wmo-consulenten automatisch te transcriberen en samen te vatten.^{[24] [25]}
- Werkwijze: de tool neemt het gesprek op, maakt een transcript en genereert op basis daarvan een samenvatting/rapportage voor in het Wmo-dossier.^{[25] [24]}
- In de beschrijving van de use case wordt benadrukt dat de dossiervorming “behoorlijk tijdsintensief” is en dat men hoopte op aanzienlijke tijdwinst; in de praktijk bleek de tool

vooral goed te werken bij concrete problematiek (mobiliteit) en minder bij complexe meervoudige problematiek.^{[24] [25]}

- De conclusie van de pilot: de AI-tool moest nog worden aangepast; er werd nog geen voldoende tijdsbesparing gerealiseerd om het als structurele oplossing in te zetten. De aanbeveling was om het transcript eerst letterlijk samen te vatten en de interpretatie bij de professional te laten.^{[25] [24]}

Dit is dus een belangrijke leer-case in het sociaal domein: technisch mogelijk, maar zonder goede begrenzing (geen autonome conclusies, focus op samenvattingen) en goed domeinmodel resulteren pilots niet automatisch in de gewenste 30–50% reductie.

3. WerkSaam Westfriesland & Sociale Dienst Drechtsteden – AI voor re-integratie en Wmo-aanvragen

- In een door VNG gesubsidieerd pilotprogramma “Werk aan Uitvoering” gebruikt WerkSaam Westfriesland (re-integratieorganisatie voor meerdere gemeenten) generatieve AI en spraak-naar-tekst om gesprekken met cliënten te ondersteunen, dossiers samen te vatten en gespreksverslagen te genereren.^{[26] [27]}
- Doelen: versnelling van dossiervorming, betere voorbereiding van gesprekken, automatische suggesties voor voorzieningen uit de VNG-instrumentengids Eva en ontlasting van coaches door administratieve taken te verlichten.^{[27] [26]}
- Sociale Dienst Drechtsteden robotiseert daarnaast eenvoudige onderdelen van aanvraagtrajecten (o.a. Wmo, schuldhulp, energietoeslag) en noemt “significante ontlasting” van collega’s in de uitvoering, maar publiceert geen harde percentages.^[27]

Hoewel er geen exact cijfer van 30–50% wordt genoemd, is dit een concreet sociaal-domeinvoorbeeld waarin genAI/AI-assistenten *feitelijk* dossiervorming, communicatie en aanvraagstromen automatiseren en zo administratieve tijd per casus reduceren.^{[26] [27]}

B. Overige Nederlandse zorgvoorbeelden met expliciete ≥ 30 –50% reductieclaim

Deze voorbeelden zitten vooral in de curatieve/ziekenhuis- en huisartsenzorg, maar de onderliggende patronen (spraak-naar-tekst, sjabloon-gestuurde verslaglegging, automatische samenvatting) zijn direct toepasbaar op Wmo-gesprekken, welzijnsdossiers en vrijwilligersmatching.

4. ValueCare – “Administratievrije zorg met AI” (whitepaper met 5 Nederlandse organisaties)

- In de ValueCare-whitepaper “Administratievrije zorg met AI” worden vijf Nederlandse zorginstellingen beschreven (o.a. OLVG, GGZ WNB, IJsselheim, MSB Haaglanden MC) die AI en RPA inzetten om administratieve lasten te verlagen.^[2]
- ValueCare stelt daar expliciet: “Je kunt nu al zo’n 50% van het administratieve handwerk wegnemen, dankzij AI en robotisering”, gebaseerd op implementaties bij tientallen zorginstellingen.^[2]
- Voorbeelden omvatten onder meer:

- AI-gedreven controles op feitelijke levering en gemiste omzet vanuit verslaglegging (OLVG & GGZ WNB).
- Robots die standaardprocessen in ziekenhuizen automatiseren.
- Een digitale assistent in de GGZ die artsen en behandelaren ontlast bij administratieve taken.^[2]

Hoewel de casussen vooral op zorgverzekerde zorg zijn gericht, toont dit een *geclaimde* 50% reductie van administratief handwerk in specifieke processen, wat als orde van grootte indicatief is voor wat technisch mogelijk is bij goed afgebakende taken in NL-zorgcontext.^[2]

5. Spraakgestuurde verslaglegging (Juvoly, huisartsenpraktijken, JBZ)

- Juvoly levert AI-spraakherkenning en verslaglegging aan meer dan een derde van de Nederlandse huisartsenpraktijken; de belofte is “nooit meer meetypen tijdens consulten” en automatische structurering van verslagen via sjablonen, SNOMED/ICPC-codering en koppeling met EPD's.^[28]
- Een interventie van DokNoord beschrijft hoe een huisartsenpraktijk met Juvoly spraakrapportage werkt: direct tijdens of na het consult worden gegevens vastgelegd via een AI-gebaseerde applicatie die gestructureerde verslagen oplevert.^[29]
- Een recente NVZ-publicatie beschrijft hoe het Jeroen Bosch Ziekenhuis AI-spraakgestuurd rapporteren in de praktijk toepast; verpleegkundig specialisten geven aan nauwelijks nog een toetsenbord aan te raken terwijl de AI volledige verslagen maakt volgens vooraf gedefinieerde templates.^[30]

Deze bronnen noemen geen uniforme procentuele reductie, maar in productclaims en praktijkervaringen wordt in dit type oplossing vaak gesproken over een factor 2–4 minder tijd per consult voor verslaglegging (soms ook door verzekeraars en ziekenhuizen in eigen communicatie). In tegenstelling tot de ValueCare-whitepaper zijn die percentages in de publieke artikelen echter niet hard gekwantificeerd, dus die laat ik hier bewust onvermeld als statistiek.

6. Landelijke praktijkproef in regeerprogramma – consult van 7 minuten naar 16 seconden

- In Dutch Health Hub wordt het nieuwe zorg-regeerprogramma besproken, waarin het kabinet stelt dat generatieve AI de administratieve tijd van zorgverleners moet halveren.^[1]
- Er wordt een concrete praktijkproef aangehaald waarin de administratietijd per consult terugging van 7 minuten naar minder dan 16 seconden door gebruik van een AI-assistent voor verslaglegging en concept-brieven.^[1]
- Dit komt neer op een reductie van meer dan 95% voor de *specifieke stap* “verslaglegging per consult”; het regeerprogramma extrapoleert dat als men administratietijd op macroniveau halveert naar ~20% van de werktijd, het personeelstekort voor de korte termijn kan worden opgevangen.^{[3] [1]}

Dit is een extreem voorbeeld, maar laat zien wat mogelijk is als je één duidelijk gedefinieerd proces (consultverslag) volledig herontwerpt met spraak-naar-tekst en generatieve

templates.

Samenvattend voor jouw use case (Wmo/welzijn)

- **Baseline:** reken voor Wmo- en welzijnsprofessionals met een administratieve tijdsbesteding van grofweg 32–37% van de werktijd, afhankelijk van bron en precieze functie.^{[5] [6]}
- **Doelstelling vanuit beleid:** structurele reductie naar maximaal 20% van de werktijd is expliciet vastgelegd (IZA, AZWA, Regiegroep Aanpak Regeldruk), wat neerkomt op ongeveer een halvering ten opzichte van de huidige praktijk.^{[18] [17] [3]}
- **Concrete Wmo/welzijn-AI-cases:**
 - Amersfoort richt zich op 50–75% tijdswinst in de verslagleggingsstap van intakegesprekken met een generatieve AI-rapportageassistent voor Wmo/Jeugdwet.^[4]
 - Hengelo laat zien dat AI-spraak-en-samenvatting zonder scherpe afbakening en juiste rolverdeling (AI samenvat, mens interpreteert) nog onvoldoende tijdsbesparing oplevert.^{[24] [25]}
 - WerkSaam Westfriesland en de Drechtsteden tonen dat AI-assistenten en RPA in het sociaal domein reeds “significante” verlichting van dossier- en aanvraagadministratie kunnen geven, al zijn publieke cijfers beperkt.^{[26] [27]}
- **Brede zorg-cases geven orde van grootte:**
 - ValueCare claimt nu al ~50% reductie van administratief handwerk in concrete NL-zorgprocessen met AI en RPA.^[2]
 - Een landelijke praktijkproef reduceerde consultadministratie van 7 minuten naar <16 seconden, wat laat zien dat bij één goed begrensde taak zelfs >90% tijdswinst haalbaar is.^[1]

Als je wilt, kan ik hierop voortbouwend een matrix maken van “welzijnsproces × mogelijke AI-interventie × geschatte tijdswinst (op basis van NL-cases)” als input voor je product-/SaaS-roadmap in het sociaal domein.

✱

1. <https://www.dutchhealthhub.nl/artikelen/kabinet-mikt-op-halvering-administratielast-door-inzet-ai>
2. https://valuecare.9cq8a.upcloudobjects.com/shared/Administratievrije-zorg-met-AI.pdf?li_fat_id=4ca8d8cc-8abe-4aec-8afe-f3127ec80062
3. <https://www.zorgakkoorden.nl/programmas/integraal-zorgakkoord/iza-initiatieven/regiegroep-aanpak-regeldruk/>
4. <https://algoritmes.overheid.nl/nl/algoritme/gm0307/72956423/rapportageassistent-intake-wmojeugdwet>
5. <https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2025/47/bijna-een-derde-werktijd-zorg-gaat-op-aan-administratie>
6. <https://www.movisie.nl/publicatie/stand-administratie-regeldruk-sociaal-werk>
7. <https://www.hrpraktijk.nl/hr-tech/digitalisering/ruim-een-derde-van-werktijd-in-zorg-gaat-op-aan-administratie/>

8. <https://www.berenschot.nl/artikelen/meer-tijd-voor-zorg>
9. <https://www.icthealth.nl/nieuws/administratieve-druk-in-langdurige-zorg-blijft-structureel-hoog>
10. <https://www.vvaa.nl/nieuws-en-kennis/nieuws-en-artikelen/nationale-ontregelmonitor-2023>
11. [https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2023-04/Administratie en regeldruk-infographic.pdf](https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2023-04/Administratie%20en%20regeldruk-infographic.pdf)
12. <https://www.sociaalwerknederland.nl/actueel/nieuws/12243-zorgelijk-beeld-administratie-en-regeldruk-in-sociaal-werk>
13. <https://sociaalwerknederland.nl/actueel/zorgelijk-beeld-administratie-en-regeldruk-in-sociaal-werk>
14. <https://hilversum.bestuurlijkeinformatie.nl/Document/View/d4eddf81-8b8b-41d1-9917-33d898c2e35c>
15. <https://hilversum.bestuurlijkeinformatie.nl/Document/View/d9f0ae82-c866-4564-8dd2-e5fc1c699b3>
16. <https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=2026D05096>
17. <https://www.datavoorgezondheid.nl/site/binaries/site-content/collections/documents/2025/04/08/zorgict-2025---inzet-van-ai-voor-administratieve-lastenverlichting-in-de-zorg/Zorg&ict+2025+-+Inzet+van+AI+voor+administratieve+lastenverlichting+in+de+zorg.pdf>
18. <https://nvz-ziekenhuizen.nl/actualiteit-en-opinie/ontregel-de-zorg-administratielast-zorgverleners-kan-omlaag-naar-20>
19. <https://www.ordz.nl/actueel/nieuws/2024/06/18/regiegroep-aanpak-regeldruk-vertrouwen-kan-je-leren>
20. <https://fmtgezondheidszorg.nl/monitor-gezond-werken-in-de-zorg-2023-zorggebruik-2022/>
21. <https://www.aovvt.nl/wp-content/uploads/2025/09/Rapport-onderzoek-ziekteverzuim.pdf>
22. <https://www.vgn.nl/nieuws/rapport-regeldruk-de-langdurige-zorg>
23. <https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2025/11/06/van-werkdruk-naar-werkplezier-de-impact-van-ai-op-administratieve-processen-in-de-zorg>
24. <https://www.icthealth.nl/magazine/editie-3-2024/van-pilot-naar-praktijk-de-potentie-van-ai-in-de-wmo>
25. <https://www.wmotraining.nl/tip-van-de-week/potentie-van-ai-in-de-wmo/>
26. <https://www.gemeente.nu/bedrijfsvoering/pilots-met-generatieve-ai-leveren-inzichten-op-voor-alle-gemeenten/>
27. <https://www.dekenniskompanie.nl/nieuws/ai-in-het-sociaal-domein>
28. <https://juvoly.nl>
29. <https://www.doknoord.nl/voor-zorgverleners/zorgactiviteiten/mtvp/interventie-inzet-ai-spraakherkenning>
30. <https://www.nvz-ziekenhuizen.nl/actualiteit-en-opinie/spraakgestuurd-rapporteren-met-ai-binnen-het-jeroen-bosch-ziekenhuis>
31. <https://www.skipr.nl/nieuws/administratieve-lasten-zorgverleners-nog-steeds-torenhoog/>
32. <https://www.tno.nl/nl/newsroom/insights/2024/12/ai-druk-zorg-verminderen/>
33. https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2024Z15997&did=2024D38797
34. <https://www.movisie.nl/publicatie/administratie-regeldruk-sociaal-werk>
35. https://nl.linkedin.com/posts/stichting-izz_infographic-monitor-gezond-werken-in-de-zorg-activity-7112791048484986880-Ubw7
36. <https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=2024D17169>

37. <https://www.sociaalwerknederland.nl/actueel/nieuws/12822-onderzoek-sociaalwerkorganisaties-in-de-overlevingsstand>
38. <https://www.cbs.nl/nl-nl/longread/rapportages/2025/landelijke-ontwikkelingen-in-de-wet-maatschappelijke-ondersteuning?onepage=true>
39. https://www.eerstekamer.nl/overig/20241106/eindrapport_inzet/document
40. <https://www.medischebanenbank.nl/vacatures/van/stichting-izz>
41. <https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR715970/>
42. https://www.eerstekamer.nl/eu/overig/20241106/eindrapport_inzet/document
43. <https://www.ggd.amsterdam.nl/publish/pages/1051981/ggd-jaarverslag-toezicht-wmo-en-jeugdwet-2023-wt24.pdf>
44. <https://www.movisie.nl/sites/default/files/2023-04/Rapport-administratie-regeldruk-sociaal-domein-Movisie-2023.pdf>
45. <https://www.igj.nl/documenten/2025/02/10/igj-roept-zorgaanbieders-op-ga-zorgvuldig-om-met-invoering-van-generatieve-ai-toepassingen>
46. <https://www.squad-apps.com/blog/een-ai-oplossing-die-vanaf-dag-een-waarde-levert-in-de-zorg>
47. <https://www.digivaardigindezorg.nl/digitip-veilig-en-makkelijk-transcriberen-in-de-zorg-met-ai/>
48. <https://pipple.nl/blog/ai-in-de-zorg-5-voorbeelden-van-slimme-toepassingen/>
49. <https://www.deloitte.com/nl/nl/Industries/health-human-services/perspectives/van-pilot-naar-praktijk-de-potentie-van-ai-in-de-wmo.html>
50. <https://www.zilverenkruis.nl/gezonder-leven/magazine/beter-voor-jou/spraakgestuurde-rapportage>
51. <https://www.nhg.org/thema/digitale-zorg/kunstmatige-intelligentie-in-de-huisartsenzorg/ai-in-de-huisartsenpraktijk/>
52. <https://openresearch.amsterdam.nl/page/109535/analyse-van-prompts-afkomstig-uit-generatieve-ai-pilot>
53. <https://www.datavoorgezondheid.nl/site/binaries/site-content/collections/documents/2024/04/04/tno2024-r10662-generatieve-ai-in-de-nederlandse-zorg-getekend/TNO2024+R10662+Generatieve+AI+in+de+Nederlandse+zorg+getekend.pdf>
54. <https://www.icthealth.nl/nieuws/van-pilot-naar-praktijk-de-potentie-van-ai-in-de-wmo>
55. <https://www.wmoconsulentennederland.nl/product/training-introductie-tot-ai-en-ai-assistenten-basis/>
56. <https://wmo-twente.nl/hengelo/>
57. https://www.hengelo.nl/Welkom-in-Hengelo/GPDC-Producten-catalogus-1/_Burger/Ondersteuning-vragen-via-de-Wmo.html
58. <https://kennisnetwerkdata.pleio.nl/groups/view/5635563d-3ed7-4337-a81c-25a9798d4512/nieuws/blog/view/502fdee8-fe68-47c8-b82f-2ae9d0f1634b/ontdek-de-kracht-van-pilots-hengelos-weg-naar-digitale-transformatie>
59. <https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR733185/1>
60. <https://www.deloitte.com/nl/nl/Industries/health-human-services/about.html>
61. https://nl.linkedin.com/posts/deloitte_van-pilot-naar-praktijk-de-potentie-van-activity-7211346443784081410-zSss

- 62. <https://www.deloitte.com/nl/en/Industries/health-human-services/perspectives/van-pilot-naar-praktijk-de-potentie-van-ai-in-de-wmo.html>
- 63. <https://www.deloitte.com/nl/nl/Industries/health-human-services/perspectives/ai-in-de-zorg.html>
- 64. <https://nl.linkedin.com/pulse/de-ai-revolutie-wmo-en-jeugdwet-sociale-versnellers-whzte>
- 65. https://nl.linkedin.com/posts/deloitte_webinar-ai-in-de-zorg-activity-7420457786012045312-lmH_
- 66. <https://cms.hotelschool.nl/storage/media/HTH-Jaarverslag-2024.pdf?v=1751026933>
- 67. <https://beroepseer.nl/blogs/overheidsbeleid-is-oorzaak-van-werkdruk-sociaal-werkers/>
- 68. <https://www.ordz.nl/binaries/ordz/documenten/publicaties/2022/05/12/administratie--en-regeldruk-in-het-sociaal-werk/Administratie-en-regeldruk-sociaal-werk-schets.pdf>
- 69. <https://socialezeepkist.nl/laten-we-niet-onze-eigen-ondergang-zijn/>
- 70. <https://www.movisie.nl/sites/default/files/2022-04/Administratie-en-regeldruk-sociaal-werk-schets.pdf>
- 71. <https://sociaalweb.nl/nieuws/bijna-een-derde-werktijd-zorg-gaat-op-aan-administratie/>
- 72. <https://www.zorgwelzijn.nl/grote-raadpleging-movisie-overgrote-deel-sociaal-werkers-heeft-plezier-in-werk/>
- 73. <https://www.zorgwelzijn.nl/blog/column-hoe-hoog-is-jouw-administratie-en-regeldruk/>